

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5072414-96.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARINA DE OLIVEIRA E SILVA

RECORRENTE: CAIO GAMA DE SAO LEAO

RECORRENTE: FLAVIA JACOB DE LIMA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM FACE DE DECISÃO RETRÔ. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A TAL RECURSO. PEDIDO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “CANABIDIOL FULL SPECTRUM GOLDEN CBD PLUS 200MG/ML - FRASCO DE 30ML”, SOB A ALEGAÇÃO DE MELHORA NO QUADRO CLÍNICO DE TEA “NÍVEL 03 SEVERO” NA SEGUNDA SEMANA DE USO. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

5072414-96.2024.4.02.5101

510014602455 .V11

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5072414-96.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARINA DE OLIVEIRA E SILVA

RECORRENTE: CAIO GAMA DE SAO LEAO

RECORRENTE: FLAVIA JACOB DE LIMA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta por **CAIO GAMA DE SÃO LEÃO, “menor impúbere”, com diagnóstico de “Deficiência Intelectual associada ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 03 severo”,** representado por sua genitora, **FLAVIA JACOB DE SÃO LEÃO,** em face da decisão proferida nos autos originários (50476938020244025101 - evento 40), que indeferiu a antecipação da tutela, por meio da qual pleiteia a condenação da UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, para fornecer o medicamento “*Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus 200mg/ml - Frasco de 30mL*”, sob a alegação de que “a partir da segunda semana” de uso do referido medicamento o jovem apresentou “melhora de extrema valia em seu quadro”.

É o breve relatório

VOTO

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão (Evento 3, DESPADEC1), a qual passa a integrar o presente voto:

“DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão proferida no processo 5047693-80.2024.4.02.5101/RJ, evento 40, DESPADEC1:

"Trata-se de demanda proposta em face da União, na qual o autor, menor representado por seu genitor, postula o fornecimento, em antecipação dos efeitos da tutela, de Canabidiol Full Spectrum Golden CDB Plus 200mg/ml - Frasco de 30ml.

O demandante, de 13 anos, possui diagnóstico de deficiência intelectual associada ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau severo e recebe acompanhamento por profissional da rede privada. O médico assistente atesta que o paciente apresenta déficit na comunicação verbal e não verbal, reciprocidade e interação social, dificuldade de função executiva e em atividades lúdicas processo 5047693-80.2024.4.02.5101/RJ, evento 1, LAUDO6.

Acrescenta que iniciou o tratamento com Periciazina (Neuleptil®), Carbamazepina, Aripiprazol, Risperidona, Cloridrato de Metilfenidato cápsulas de liberação modificada (Ritalina LA®), Imipramina, Cloridrato de Metilfenidato (Attenze®), que, todavia, não surtiram o efeito esperado, já que o paciente estava muito agitado, agressivo ao extremo, com insônia, tontura, euforia, entre outros sintomas relacionados aos medicamentos.

Segundo o parecer do Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde processo 5047693-80.2024.4.02.5101/RJ, evento 35, PARECER1, o canabidiol não integra nenhuma lista de produtos e/ou medicamentos dispensados pelo SUS, pois não possui registro na ANVISA.

Por um lado, o direito de acesso às ações de saúde foi objeto de especial tutela pelo legislador constituinte, como demonstra o teor do art. 196 da Constituição da República, que prevê acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção da saúde. Tal direito de acesso às ações de saúde confunde-se com o próprio direito à vida, assegurado no caput do art. 5º da Carta Magna.

Tal direito é garantido por meio da adoção de políticas sociais e econômicas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

Em contrapartida, da leitura da norma, não se pode concluir que o Estado esteja obrigado ao fornecimento de todo e qualquer tratamento médico ou medicamento, mas apenas daqueles inseridos em políticas públicas previamente elaboradas pelo Poder Executivo, que detém a competência para planejar e executar ações preventivas e curativas, em consonância com as limitações orçamentárias.

Discutindo os limites da jurisdicionalização do acesso à saúde, o Min. Gilmar Mendes, quando do julgamento das suspensões de tutela antecipada nos 175 e 178, estabelece o seguinte parâmetro:

"Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de uma omissão legislativa ou administrativa, de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou de uma vedação legal a sua dispensação.(...) Dessa forma, podemos concluir que, em geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente" (STF, STA nº 175, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 25.09.2002).

No caso, o produto não compõe a listagem de fármacos padronizados nem possui registro na Anvisa, o que constitui, em princípio, óbice ao seu emprego no SUS, por força da Lei n.º 12.401/2011, que introduziu o seguinte dispositivo na Lei n.º 8.080/90:

Art. 19-T. São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS:

II- a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa.

A flexibilização dessa regra, admitida em caráter excepcional pela jurisprudência, condiciona-se à satisfação de certos requisitos, delineados no julgamento do RE 657.718/MG, afetado como tema de repercussão geral, a partir do qual se fixou a seguinte tese:

- 1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.*
- 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.*
- 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.*

De sua leitura, a começar pela primeira exigência para a mitigação excepcional da vedação ao fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, é imperiosa a comprovação de sua eficácia no tratamento da patologia, uma vez que o "Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais".

Nesse ponto, o parecer do NAT esclarece que estudos preliminares acerca do emprego de canabidiol no tratamento de crianças com transtornos de comportamento ainda não apresentam evidência científica robusta apta a inferir a eficácia e segurança de sua utilização. Confira-se o excerto:

"as evidências disponíveis ainda se apresentam em níveis baixos ou inconclusivos, o que expressa a necessidade de mais estudos com diferentes metodologias para determinar possível benefício terapêutico e segurança do tratamento com canabinoides para as mais diversas condições de saúde¹⁰. 6. Considerando todo o exposto acima, conclui-se que são escassas as evidências científicas que apoiam o uso de produtos derivados de Cannabis para o manejo do quadro clínico do Autor. 7. Dessa forma, quanto à indicação do produto pleiteado, destaca-se que até o momento não há registrado no Brasil medicamento de Canabidiol com indicação para o tratamento de transtorno do espectro autista."

A despeito de exaurido o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo, que prescreve o uso de risperidona, o insumo pleiteado ostenta caráter experimental para tratamento do autismo.

Indefiro, assim, a concessão de tutela de urgência, pois, para tanto, não basta apenas a satisfação do requisito de risco de dano, restando pendente de comprovação a evidência do direito alegado, tal como exige o art. 300 do CPC.

Citem-se os réus, para apresentação de resposta no prazo de 30 dias, oportunidade em que deverão trazer aos autos os documentos de que disponham para a solução da lide, nos termos do art. 11 da Lei nº 10.259/2001, **notadamente acerca do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do SUS para tratamento do quadro desenvolvido pela parte autora e da existência de alternativas terapêuticas.**

Tudo cumprido, **remetam-se** os autos ao Ministério Público Federal.

Em seguida, voltem conclusos."

É o breve relatório.

A parte autora comprovou que recebeu o diagnóstico, conclusivo de transtorno do espectro autista (TEA) nível 03 "severo" associado a deficiência intelectual (DI) estabelecido conforme critérios estabelecidos no DSM-V.

Foi realizada, corretamente, a intimação do Núcleo de Assistência Técnica, NAT, para emissão de parecer, nos termos do que dispõe o Enunciado 13 do CNJ: "Nas ações de saúde que pleiteiam o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde - SUS, com vistas a, inclusive, identificar solicitação prévia do requerente, alternativas terapêuticas e competência do ente federado, quando aplicável (Saúde Pública e Suplementar). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)"

O NAT juntou parecer no evento 35, PARECER1.

O NAT concluiu que que o produto Canabidiol 200mg/mL Full Spectrum Golden Plus não possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e não está padronizado em nenhuma lista oficial do SUS.

Afirmou, ainda, que são escassas as evidências científicas que apoiam o uso de produtos derivados de Cannabis para o manejo do quadro clínico da parte autora.

O Enunciado nº 83 do CNJ ressalva a importância de evidência científica na análise do pedido.

Colhe-se do enunciado:

"Poderá a autoridade judicial determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a juntada ao processo de documentos de evidência científica (nota técnica ou parecer) disponíveis no e Natjus (CNJ) ou em bancos de dados dos Núcleos de Assessoramento Técnico em Saúde (NATS) de cada estado, desde que relacionados ao mesmo medicamento, terapia ou produto requerido pela parte."

O Tema 106 estabeleceu a necessidade do cumprimento de certos requisitos, no caso de medicamentos não incorporados ao SUS:

TEMA 106 - MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS - REQUISITOS

"Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS".

Tese Firmada: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência".

Ainda, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 657718, pela sistemática da repercussão geral (tema 500), em acórdão publicado no DJE nº 117, divulgado em 31/05/2019. Na ocasião, o Supremo fixou as seguintes teses:

"1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.

2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.

3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.

4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União."

Além de não constar na tese fixada qualquer referência a questão do fornecimento de medicamentos para uso off label, é possível se extrair do voto vista do Exmo. Ministro Dias Toffoli as seguintes considerações:

"Faço, por fim, três ponderações.

A primeira: a conclusão a que se chegou nestes autos quanto ao registro na ANVISA como condição necessária ao fornecimento da medicação pelo SUS não se relaciona com a hipótese de fornecimento off label do medicamento, hipótese na qual o fármaco é registrado na agência, mas o uso requerido foge da indicação contemplada em sua bula.

Embora a ANVISA proceda ao registro dos medicamentos para específica finalidade, não se pode afirmar que, por isso, o medicamento, quando indicado para finalidade diversa, não conta com registro da agência reguladora. O registro em tal caso existe. O uso do medicamento é que está dissociado da indicação para a qual foi registrado.

Assim, a celeuma que se dá quanto à possibilidade de se obrigar o sistema a fornecer medicação para indicação diversa da registrada na ANVISA - hipótese que também conta com vedação legal expressa no art. 19-T, I, da Lei nº 8.080/90 - não se refere à travada aqui nestes autos.

Digo isso apenas para esclarecer o alcance do que está sob julgamento nos presentes autos, de modo que essa espécie de apreciação seja realizada nos autos adequadamente."

A tese fixada no Tema 106 do C. STJ é no sentido de que o fornecimento de medicamentos deve observar a "existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência".

Essa Turma Recursal, em processos análogos, firmou o entendimento que diante de evidências científicas insuficientes resta caracterizada a impossibilidade do Estado em fornecer medicamentos ou produtos experimentais.

SAUDE. CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI 200 MG/ML. TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA). EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS INSUFICIENTES. MANIFESTAÇÃO DO NAT E DA FIOCRUZ PELA NECESSIDADE DE ESTUDOS. IMPOSSIBILIDADE DO ESTADO FORNECER MEDICAMENTO OU PRODUTOS EXPERIMENTAIS. TEMA 500 DO STF. (Sessão do 23/05/2023, Sessão Virtual, Processo 31 da Pauta, Processo nº 5004147-56.2021.4.02.5108. Rel. Dra. Daniella Motta)

Assim está ausente a probabilidade do direito pleiteado.

Por essas razões, defiro o requerimento liminar de atribuição de efeito suspensivo ativo, para que seja indeferida a tutela antecipada concedida .

Intimem-se."

Logo, não estava, ainda, demonstrada a existência de verossimilhança nas alegações e do risco de lesão grave e/ou de difícil reparação, para que pudesse ser concedido efeito suspensivo ativo.

Por tais razões, **VOTO** por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar.